

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

La vacunación es una de las **intervenciones de salud pública más seguras y efectivas**. Sin embargo, como cualquier acto médico, no está exenta de riesgos. En raras ocasiones pueden presentarse **Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunación o Inmunización (ESAVI)**.

En Chile, todos los eventos adversos son **monitoreados y notificados** a través de un sistema nacional coordinado por el **Instituto de Salud Pública (ISP)** y el **Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI)** del **Ministerio de Salud**.

El manejo correcto de estos eventos y la identificación de **contraindicaciones absolutas y relativas** son competencias fundamentales del médico general y constituyen un foco de evaluación frecuente en el **EUNACOM**, tanto desde la perspectiva clínica como de salud pública.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1. Definición de ESAVI

“Cualquier evento médico no esperado que ocurre después de la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con la administración de la vacuna.”
(OMS / MINSAL, 2023)

Los ESAVI incluyen **reacciones adversas, coincidencias temporales, errores programáticos, reacciones por ansiedad y eventos indeterminados**.

2.2. Clasificación de los ESAVI

Tipo	Descripción	Ejemplo
Reacción relacionada con la vacuna	Efecto causado por los componentes de la vacuna.	Fiebre leve post DTP.

Error programático	Asociado a una técnica de administración inadecuada.	Absceso por mala antisepsia.
Coincidencia temporal	Evento no causado por la vacuna.	Infección respiratoria post vacuna.
Reacción relacionada con ansiedad	Síntomas psicogénicos post vacunación.	Lipotimia, hiperventilación.
Evento indeterminado	No se puede establecer causalidad.	Convulsión sin causa evidente.

2.3. Importancia del monitoreo de ESAVI

- Mantiene la **seguridad pública y confianza comunitaria**.
 - Permite **identificar errores programáticos y brotes secundarios**.
 - Facilita **acciones correctivas y vigilancia farmacológica**.
 - Es una **obligación legal y ética** del personal de salud (Ley 19.937).
-

3. Fisiopatología y bases conceptuales

Las reacciones vacunales se deben a tres mecanismos principales:

1. **Respuesta inmunológica normal:** producción de anticuerpos y citocinas que generan fiebre o inflamación local leve.
2. **Hipersensibilidad inmediata o mediada por IgE:** desencadena reacciones alérgicas graves (anafilaxia).
3. **Respuesta inflamatoria sistémica desproporcionada:** fiebre alta, mialgias o convulsiones febriles.

Las vacunas **vivas atenuadas** (SRP, varicela, fiebre amarilla) tienden a generar reacciones leves por replicación viral limitada, mientras que las **inactivadas** y **toxinas** producen reacciones locales autolimitadas.

4. Clínica: manifestaciones y diagnóstico diferencial

4.1. Reacciones locales (frecuentes, leves)

- Dolor, eritema, induración, calor.
- Aparecen 6–24 h post vacunación, duración <48 h.
- Ejemplo: reacción local tras DTP o dTpa.

Manejo: compresas frías, analgesia leve, sin antibióticos.

4.2. Reacciones sistémicas leves

- Fiebre <38,5 °C, malestar, somnolencia.
- Usuales tras SRP, DTP o influenza.

Manejo: antipirético si es necesario.

4.3. Reacciones moderadas a graves

Tipo	Ejemplo	Frecuencia estimada	Manejo
Fiebre >39,5 °C	Post DTP o SRP	<1 %	Control térmico, observación.
Convulsiones febriles	SRP, DTP	1/10.000	Evaluar causas; generalmente benignas.

Anafilaxia	Cualquier vacuna	1–2 por millón	Adrenalina 0,01 mg/kg IM, soporte vital.
Trombocitopenia transitoria	SRP	1/30.000	Observación, autolimitado.
Absceso estéril	Error programático	Variable	Manejo local y notificación.

4.4. Diagnóstico diferencial

Los eventos post vacunales deben diferenciarse de:

- Coincidencias temporales (virus respiratorios).
- Infecciones bacterianas no relacionadas.
- Reacciones alérgicas a medicamentos concomitantes.
- Eventos neurológicos preexistentes (epilepsia, síncope).

Criterio orientador: una reacción verdaderamente vacunal suele aparecer dentro de las primeras **48 horas**, con evolución autolimitada y sin signos infecciosos sistémicos.

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En la mayoría de los casos leves, **no se requieren exámenes complementarios**.

En casos graves o inusuales, se indica:

- Hemograma y PCR si hay fiebre persistente.
- Cultivo o PCR si se sospecha infección bacteriana.
- Serología si se evalúa respuesta inmune insuficiente.
- Informe clínico detallado para investigación por ISP.

Diagnóstico de ESAVI: clínico-epidemiológico, apoyado por antecedentes vacunales, cronología y exclusión de otras causas.

6. Manejo y tratamiento según guías MINSAL

6.1. Medidas generales

- Observación **30 minutos post vacunación** en todo usuario.
 - Disponer de **kit de emergencia** con adrenalina y equipo básico de reanimación.
 - Evaluar antecedentes de alergia o reacciones previas antes de vacunar.
-

6.2. Manejo de reacciones leves

- Compresas frías locales.
 - Paracetamol si fiebre $>38,5^{\circ}\text{C}$.
 - Reposo y control domiciliario.
-

6.3. Manejo de anafilaxia post vacunación

1. **Suspender administración** y colocar paciente en decúbito supino.
 2. **Administrar adrenalina IM (0,01 mg/kg)** en cara anterolateral del muslo.
 3. Oxígeno suplementario y líquidos IV.
 4. Derivar a urgencia y **notificar de inmediato** al PNI / SEREMI.
 5. Observar al menos 6–8 h posterior al evento.
-

6.4. Notificación y vigilancia de ESAVI

La **notificación es obligatoria** para todo el personal de salud (Decreto 6/2010).

Pasos:

1. Completar formulario **ESAVI** en establecimiento.
2. Notificar dentro de **24 h** a **SEREMI de Salud**.
3. SEREMI remite a **ISP** para análisis de causalidad.
4. El ISP clasifica el evento (relacionado, coincidente, indeterminado).
5. Retroalimentación a nivel local y registro en sistema **REM**.

Ejemplo: Convulsión post SRP → notificar incluso si se resuelve sin secuelas.

7. Contraindicaciones de vacunación

7.1. Contraindicaciones absolutas

Vacuna	Condición	Observación
Cualquier vacuna	Reacción anafiláctica previa a la misma o a un componente	Contraindicación permanente.
SRP, Varicela, Fiebre amarilla, BCG	Inmunosupresión grave (VIH con CD4 <200, quimioterapia, corticoides ≥2 mg/kg/día)	Vacunas vivas atenuadas contraindicadas.
BCG	Peso <2.000 g o hijo de madre VIH+	Se posterga hasta cumplir criterios.
Influenza / COVID-19	Alergia grave a componente específico (p. ej. huevo, polietilenglicol)	Evaluación por especialista.

7.2. Contraindicaciones relativas o temporales

Situación	Manejo
Fiebre >38 °C o infección aguda grave	Postergar hasta recuperación.
Embarazo	Evitar vacunas vivas (SRP, varicela, fiebre amarilla, BCG).
Corticoterapia breve (<14 días) o dosis baja	No contraindica vacunación.
Antibióticos o tratamiento crónico	No contraindica.

7.3. Falsas contraindicaciones (errores frecuentes en EUNACOM)

- Resfrío leve o fiebre baja.
- Lactancia materna.
- Uso de antibióticos.
- Historia familiar de convulsiones o alergias.
- Prematurez sin inestabilidad.

☐ Ninguna de las anteriores impide vacunar.

8. Complicaciones y pronóstico

La gran mayoría de los eventos adversos vacunales son **leves y autolimitados**.

Solo un porcentaje ínfimo (<0,001 %) genera hospitalización.

Complicaciones raras:

- Absceso estéril (error técnico).
- Encefalopatía post DTP (extremadamente infrecuente).
- Guillain-Barré post influenza o COVID-19 (asociación incierta).

Pronóstico: excelente con manejo precoz y notificación oportuna.

9. Rol del médico general en APS

Función	Descripción
Prevención primaria	Evaluar antecedentes, aplicar vacunas seguras, observar post inoculación.
Vigilancia sanitaria	Notificar ESAVI al sistema nacional.
Educación comunitaria	Explicar reacciones normales y cuándo consultar.
Gestión local	Supervisar cadena de frío y técnica correcta de vacunación.
Participación intersectorial	Coordinar con SEREMI y equipos de epidemiología.

El médico general actúa como **primer eslabón de detección y respuesta** ante cualquier evento post vacunación, contribuyendo a la **transparencia y seguridad del PNI**.

10. Errores comunes en EUNACOM

Error	Corrección

Pensar que toda fiebre post vacuna indica contraindicación futura	Solo anafilaxia o reacción grave contraindica repetir.
Omitir notificación de reacciones leves	Todo ESAVI debe notificarse (obligatorio).
Administrar SRP o BCG en inmunodeprimidos	Contraindicado.
Creer que lactancia o fiebre leve impiden vacunar	No contraindican.
No disponer de adrenalina en sala de vacunación	Es requisito legal del PNI.
Confundir ESAVI con evento coincidente	La causalidad se evalúa posteriormente por ISP.

11. Normativa y referencias ministeriales

- MINSAL (2024): Esquema Nacional de Vacunación – PNI.
- Manual del Vacunador (MINSAL, 2023).
- Normas Nacionales de Vigilancia de ESAVI (ISP, 2022).
- Decreto Supremo N° 6 / 2010: Reglamento sobre Inmunizaciones.
- OPS/OMS: Estrategia Mundial de Inmunización 2030.
- Estrategia Nacional de Salud 2021–2030.

12. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Los **ESAVI** son eventos que ocurren después de una vacunación, sin implicar necesariamente causalidad.
2. Todo evento sospechoso debe **notificarse dentro de 24 h** a la **SEREMI** y al **ISP**.
3. Las **reacciones leves** (dolor, fiebre baja) son frecuentes y autolimitadas.
4. Las **reacciones graves** (anafilaxia, convulsión) son excepcionales pero requieren **manejo inmediato**.
5. Las **contraindicaciones absolutas** son pocas: anafilaxia previa y vacunas vivas en inmunodeprimidos o embarazadas.
6. La **lactancia, infecciones leves o antibióticos** no son motivo para postergar vacunación.
7. El médico general debe dominar la **detección, manejo y notificación** de ESAVI, garantizando la **seguridad del PNI** y la confianza pública.